SENTENÇA

[Planos de saúde, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
0879839-24.2024.8.15.2001
AUTOR: VERONICA DE JESUS MAGALHAES CORREIA
REU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Visto etc.

Visto etc.

Trata-se de **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** proposta por **VERONICA DE JESUS MAGALHAES CORREIA** em face da **GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.**

A autora narra que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré e foi diagnosticada com Macroglobulinemia de Waldenström (CID C88.0), um tipo raro de câncer. Afirma que seu médico assistente, Dr. Gilson Espínola Guedes Filho (CRM/PB 2.946), prescreveu, como tratamento indispensável, o uso contínuo e vitalício do medicamento **Imbruvica (Ibrutinibe) 420mg**.

Relata que, ao solicitar a cobertura do fármaco, a ré negou o fornecimento sob o argumento de que o quadro clínico não preenchia os critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização (DUT) da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Diante da negativa e da urgência do tratamento, pleiteou a concessão de tutela de urgência para que a ré fosse compelida a fornecer o medicamento. Ao final, requereu a confirmação da liminar, tornando definitiva a obrigação de custeio do tratamento, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A petição inicial (ID 105756677) veio acompanhada de documentos, incluindo laudos médicos e a negativa de cobertura.

A tutela de urgência foi deferida em regime de plantão (ID 105759459), determinando-se à ré que autorizasse e custeasse o tratamento com o medicamento prescrito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A ré interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado efeito suspensivo, tendo o seu desprovimento sido confirmado em julgamento colegiado pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal (IDs 106341325 e 117100027).

Devidamente citada, a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE apresentou contestação (ID 106221040), arguindo, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por ser entidade de autogestão e a legalidade da recusa, uma vez que o tratamento solicitado não atenderia às diretrizes do rol da ANS, que defende ter natureza taxativa. Alegou, ainda, a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais.

Houve réplica à contestação (ID 112629142).

No curso do processo, a autora noticiou o descumprimento da liminar, com atraso na entrega do medicamento (IDs 108970645 e 109534828), o que foi justificado pela ré em razão de dificuldades logísticas com a importação do fármaco (ID 109743419). Em decisão posterior (ID 112008012), foi determinado que a ré realizasse a entrega das futuras caixas do medicamento com antecedência mínima de 10 dias.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a ré pugnou pela realização de consulta a órgãos técnicos como CONITEC e NATJUS (ID 123987256), enquanto a autora requereu o julgamento antecipado do mérito (ID 124142741).

Este Juízo, para melhor elucidação da matéria técnica, determinou a elaboração de Nota Técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus (ID 128738744), a qual foi juntada aos autos sob o ID 129018033.

As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. **DECIDO.**

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Dispõe o CPC, em seu artigo 355, inciso I, que é permitido ao Julgador apreciar antecipadamente o mérito, através de sentença com resolução de mérito, quando julgar desnecessária a produção de novas provas.

Desta feita, considerando que a causa já se encontra madura o suficiente para ser julgada, bem como em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade, é imperativo julgar antecipadamente o feito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside na legalidade da recusa da operadora de saúde em custear o medicamento **Imbruvica (Ibrutinibe)**, prescrito à autora para tratamento de **Macroglobulinemia de Waldenström**.

A parte autora, idosa de 67 anos à época do ajuizamento da ação, comprovou, por meio de laudos médicos (IDs 105756670 e 105756668), ser portadora de **neoplasia maligna rara e agressiva.** A prescrição médica, firmada por profissional especialista em oncologia, foi clara ao indicar o uso do referido fármaco como terapia essencial à sua condição de saúde (ID 105756667).

A recusa da operadora está pautada unicamente na alegação de que a combinação medicamentosa não atende aos critérios da Diretriz de Utilização (DUT) da ANS. Contudo, a jurisprudência dominante é clara ao estabelecer que, havendo cobertura para a doença de base — câncer—, é abusiva a negativa de tratamento prescrito pelo médico assistente, notadamente quando se trata de fármaco registrado na ANVISA e cientificamente comprovado.

Após a vigência da Lei nº 1.454/2022, consolidou-se o entendimento de que o rol da ANS constitui uma "referência básica para os planos privados de assistência à saúde", conforme passou a dispor o §12 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. Portanto, atualmente, o rol da ANS funciona como um piso mínimo de procedimentos que os planos de saúde são obrigados a cobrir. A recusa de um tratamento com base unicamente em sua ausência no rol é considerada ilegal e abusiva se o procedimento ou medicamento atender a pelo menos um dos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.454/2022.

Assim, a nova lei determinou que um tratamento ou procedimento prescrito pelo médico, mesmo que não esteja no rol, deve ter cobertura obrigatória se preenchido um dos seguintes critérios estabelecidos no §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998:

> § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
>
> I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
>
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão

de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Em se tratando de tratamento oncológico, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que é irrelevante a discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, sendo a cobertura obrigatória.

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . EXAME PET-CT. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE . ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA ABUSIVA . DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE . REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de exame PET-CT oncológico (PET-SCAN) para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio. 2. **O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo Precedentes irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.** . 3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos . 5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas

> quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6 . Agravo interno não provido. (STJ AgInt no REsp: 2137002 SP 2024/0132213-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024

No presente caso, a necessidade e a adequação do tratamento foram robustecidas pela **Nota Técnica nº 443212**, elaborada pelo NATJUS-PB (ID 129018033), a pedido deste Juízo. O parecer técnico, isento e fundamentado, foi conclusivo e corroborou integralmente a indicação médica.

A Nota Técnica destacou que o medicamento Ibrutinibe possui registro válido na ANVISA e que sua indicação está em conformidade com o aprovado no registro. Analisando a literatura científica, citou múltiplos ensaios clínicos (como iNNOVATE, Buske et al., 2022) que demonstram a "eficácia consistente" e a "superioridade clara" do ibrutinibe para o tratamento da Macroglobulinemia de Waldenström, com "controle de doença durável".

Ao final, a conclusão do órgão técnico foi taxativa:

CONSIDERA-SE, de forma favorável, pela necessidade de fornecimento do medicamento ibrutinibe para o tratamento da paciente supracitada, por se tratar de terapia indicada, baseada em evidências científicas e benéfica no controle da patologia.

Portanto, a recusa da ré mostra-se ilegal e abusiva, pois contraria a prescrição médica, a legislação aplicável, a jurisprudência consolidada e a análise técnica especializada e imparcial que atesta a eficácia e a necessidade do tratamento para a condição da autora.

DOS DANOS MORAIS

A autora pleiteia indenização por danos morais. A conduta da ré impôs à autora, pessoa idosa e em tratamento contra um câncer, a incerteza quanto à possibilidade de dar continuidade a um tratamento vital.

O dano moral, neste contexto, é evidente. A recusa indevida em momento de fragilidade da saúde transcende o mero aborrecimento, violando a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde.

A frustração da expectativa legítima da consumidora em ter acesso ao tratamento contratado configura o ato ilícito indenizável.

Em vista disso, impõe-se a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve ser fixado em observância aos princípios da **razoabilidade e proporcionalidade**, considerando a gravidade da falta praticada, a natureza da doença e a capacidade econômica do ofensor.

Diante das circunstâncias do caso, da condição clínica da autora e do caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por dano moral em **R$5.000,00 (cinco mil reais)**.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial para **CONFIRMAR** a tutela de urgência concedida na decisão de ID 105759459, tornando definitiva a obrigação da **GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE** de fornecer à autora, **VERONICA DE JESUS MAGALHAES CORREIA**, o medicamento **Imbruvica (Ibrutinibe)**, na dosagem e posologia prescritas pelo médico assistente, de forma contínua e por tempo indeterminado, enquanto perdurar a indicação terapêutica e **CONDENAR** a ré, **GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE**, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de **R$5.000,00 (cinco mil reais).**

Para DANOS MORAIS: Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). No período compreendido entre o evento danoso e o arbitramento, em que incidirá tão somente juros moratórios, deve ser aplicada a Taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, §1º, CC). Após o arbitramento, em que haverá cumulação de encargos (juros e correção monetária), deverá incidir a Taxa SELIC isoladamente.

Assim, , condeno a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários ao patrono do autor em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Interpostos embargos declaratórios, intime a parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões.

Em caso de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazoar, caso tenha integrado a lide, e após remetam-se os autos ao E. TJPB, independente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, conforme disposição do art. 534 do NCPC, determino a intimação do exequente para requerer a execução do julgado e apresentar memória discriminada do cálculo, no prazo de 15 dias. Em caso de inércia, arquive-se.

Publicado e registrado eletronicamente. Intimem-se.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
07/01/2026 13:31:22
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 131069725

26010713312244600000012

IMPRIMIR GERAR PDF